

Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do procedimento/atividade: Regulação e agendamento da Agenda SMS - CONSULTA EM BUCOMAXILOFACIAL		Versão:
Data de elaboração: 08/12/2025	Perspectiva de revisão: ANUAL	Responsável pela elaboração do POP: Viviane Paula Panisson
Setor: Gerência de Regulação em Saúde -SMS		Responsáveis pela tarefa: Viviane Paula Panisson
Conceito / Definição: O Procedimento Operacional Padrão (POP) para o médico regulador é um documento que visa padronizar os processos de regulação e agendamento de procedimentos na instituição de saúde. Sua elaboração busca estabelecer diretrizes claras que garantam a consistência no atendimento e a eficiência operacional, promovendo um fluxo de trabalho organizado e eficaz entre a equipe médica e administrativa.		
Objetivos e Resultados esperados: Os objetivos do POP incluem aprimorar a eficiência operacional e reduzir o tempo de espera dos pacientes, além de melhorar a comunicação entre os membros da equipe. Espera-se que essa padronização contribua para a qualidade do atendimento, assegurando conformidade com as normas de saúde e aumentando a satisfação dos pacientes. O documento também servirá como uma ferramenta de treinamento e capacitação para novos colaboradores e permitirá o monitoramento contínuo dos processos, resultando em melhorias constantes e na otimização dos recursos da instituição.		
Documentos de referência: https://regulacaosmsfloripa.com/wp-content/uploads/2025/08/CBMF-25_set_2024.pdf		
Descrição do procedimento Regulatório: Classificação de risco conforme PROTOCOLO. - Gestante sem tempo hábil para agendamento devido idade gestacional avançada (acima 28a semana): agendar para pós-parto após 2 meses (amarela com data editada- lactantes até 06 meses- prioridade alta ou máxima).		



- **Terceiros molares com lesão óssea ou impactado causando cárie em segundo molar:** amarelo com prioridade ALTA ou MÁXIMA, de acordo com a situação clínica descrita (preferencialmente verificar imagem de radiografia ou pedir pra anexar no prontuário para justificar priorização).
- AMARELO prioridade ALTA: **Exodontias múltiplas com necessidade de alveoloplastia em pacientes P0 para PT** ou exo terceiro molar PO PT.
- Frenecto acima de 06 anos: podem ser aceitos encaminhamento de médicos e de fono, desde que não peçam avaliação. Classificar com prioridade amarela (prioridade máxima para criança até 12 anos).
- Exodontia complexa com fatores de retenção: quando tem rx anexado e é possível identificar o grau de dificuldade, classifico como AMARELO. Se não tiver rx, questiono se foi realizada a tentativa de exo no CS, se não, oriento matriciamento (terceiros molares inferiores geralmente não precisa matricular).
- **Pacientes imunocomprometidos: prioridade ALTA na classificação de acordo com a situação clínica.**
- Se Rx anexado SEMPRE verificar a imagem, pois muitos descritos como “inclusos” são, na verdade, “semi-erupcionados”.
- Totalmente incluso (independente da idade) e parcialmente erupcionado em paciente acima de 35 anos- orientação é realizar preservação clínica e radiográfica. Se informar que tem patologia regular com a informação: INCLUSO/ PARC ERUP acima de 35 anos com patologia associada ou matriciamento realizado ok.
- Totalmente impactados somente associado a patologia (independente da idade)- matriciamento prévio compulsório
- Semi-erupcionados acima de 35 anos somente se tiver patologia associada (Acima de 35 anos: a partir de 36). Na dúvida se está totalmente incluso, avaliar rx ou perguntar: “trata-se de terceiro molar totalmente incluso? São considerados totalmente inclusos os dentes que apresentam-se totalmente intra-ósseos sem solução de continuidade com o tecido gengival”.
- Dente semi erupcionado acima de 35 anos- histórico de pericoronarite- questiono se já teve registro da patologia em prontuário. (Dente parcialmente incluso e impactado- acima de 35 anos associado a patologia/ ou matriciamento ok)
- Gestante e criança: prioridade máxima ou alta na cor a que se refere à situação clínica
- Supranumerário totalmente incluso: verificar se tem patologia associada.



- Dente presente na boca (erupcionado) e em posição vertical, orientar que a exodontia é de responsabilidade do dentista da APS.
- Infecção recorrente: Necessário informar as datas dos atendimentos de dor/ infecção. Para fins de classificação de prioridade, considera-se um mesmo episódio intervalos menores de 10 dias (intervalos menores de 10 dias entre as consultas, consideramos um mesmo episódio de agudização, para fins de classificação de prioridade, por mais que tenha transcorrido mais de 1 consulta para manejo).

Descrição do procedimento de Agendamento:

Considerar:

- a) Agendamentos somente de 1ª vez. Os retornos são agendados na consulta em vaga interna do CEO.
- b) Preferencialmente segurar uma vaga para 15 dias caso surja alguma urgência.
- c) Agendamento manual de acordo com proximidade (se colocar no lote vai agendar a maioria pro centro- colocar a unidade)
- obs: a primeira consulta é somente uma avaliação. Não será realizado o procedimento cirúrgico neste primeiro momento.

Prazos e tempo de execução: A classificação de risco deve ser realizada em até 7 dias, e o agendamento deve ser feito conforme a disponibilidade de oferta, respeitando a fila de espera regulada ou cronológica.

Habilidades necessárias: Conhecimento técnico

Materiais e equipamentos envolvidos na tarefa: Computador.

Sistemas e programas utilizados para atividade: Celk Saúde Florianópolis.

Limitações externas: CID incompatível com o procedimento; código de procedimento não habilitado no sistema; AIH ilegível.

Meio em que será disponibilizado: Site PMF; Drive Gerência de Regulação;